

“Dan is er nog een belangrijke ontwikkeling bij uitgezaaide blaaskanker”, zegt Ronald de Wit. Patiënten die werden behandeld met chemotherapie bij uitgezaaide blaaskanker konden, als ze na vier of zes kuren een respons of ten minste stabiele ziekte hadden, deelnemen aan de studie JAVELIN bladder 100.

In deze studie vond een loting plaats voor een onderhoudsbehandeling met de immuuntherapie avelumab of de standaard zorg. De standaard zorg is dat er iedere drie maanden een scan wordt gemaakt en dat wordt afgewacht tot er weer ziekteprogressie is en dat dan eventueel immuuntherapie wordt gegeven.

“De JAVELIN bladder 100 studie was heel positief. Want er was ruim een half jaar overlevingswinst bij het vroeg geven van immuuntherapie.”

Ronald de Wit licht toe: “Dat komt voor een deel doordat het ‘geselecteerde’ patiënten zijn; zij die al respons hadden op de chemotherapie. Als we immuuntherapie geven in aansluiting op de chemotherapie die al respons gaf dan geeft dat blijkt nu dus een half jaar overlevingswinst.”

Hij verwacht dat de immuuntherapie avelumab in de loop van 2021 ook in Nederland wordt goedgekeurd als onderhoudsbehandeling bij uitgezaaide blaaskanker.

Stichting DUOS werkt aan een nieuwe studie, ook met de immuuntherapie avelumab. “In die studie willen we onderzoeken of de immuuntherapie veel korter kan”, zegt Ronald de Wit. “In de JAVELIN-studie kregen mensen immuuntherapie tot de ziekte terugkeerde. Dat duurde soms wel twee of drie jaar. Dat is wel heel belastend voor een patiënt. Zeker omdat die immuuntherapie eens in de twee weken werd gegeven. In de nieuwe

studie willen we onderzoeken of het voldoende is om de immuuntherapie gedurende een half jaar te geven. We gaan ook kijken of we die immuuntherapie eens in de drie of vier weken kunnen geven in plaats van eens in de twee weken. We verwachten dat de studie begin 2021 zal starten.”

Tot slot noemt Ronald de Wit nog de resultaten van twee grote studies, die zijn gepresenteerd tijdens het ESMO 2020 congres. De ene was de KEYNOTE 361. Daarin werd chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij uitgezaaide blaaskanker vergeleken met chemotherapie plus de immuuntherapie pembrolizumab. “Daaruit bleek dat immuuntherapie samen met chemotherapie een overlevingswinst geeft van 2,5 maand. Dat verschil was te klein om statistisch significant te zijn. En daarmee ook een te klein verschil om het klinisch aan te bevelen om er een combinatie van te maken.”

De andere studie was DANUBE. Daarin werd ook chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij uitgezaaide blaaskanker vergeleken, maar nu met chemotherapie en twee immuuntherapieën, namelijk durvalumab en tremelimumab die samen werden gegeven. Ook uit deze studie bleek geen significante overlevingswinst.

Ronald de Wit besluit: “Dat maakt dat de volgorde van behandeling bij uitgezaaide blaaskanker gelijk blijft. Dus om immuuntherapie pas te geven na eerdere chemotherapie, als de ziekte terugkeert of niet respondeert op de chemotherapie, of zoals genoemd in aansluiting op een respons op chemotherapie zoals in de JAVELIN-studie (na registratie).”

Meer informatie: de studies en deelnemende ziekenhuizen vindt u op www.stichtingduos.nl of stel uw vragen aan uw behandelaar.